

Vacunas

El papel de las vacunas en pacientes con EPOC

Fecha de elaboración: Abril 2024
Código PPT: NX-CO-RS-PPT-240019
Código video: NX-CO-RS-VID-240019

Conflictos de Interés

Pagos por conferencias, asistencia a congresos y consultoría	Zambon, Novartis, Boehringer Ingelheim, GSK, Bayer, Glenmark, AZ, Sanofi, Novonordisk y Grupo Amarey, Carnot Laboratorios
Acciones o relaciones familiares con la industria farmacéutica	No
Relación con la industria del tabaco	No
Participación en guías de practica clínica	No
Ocupación e investigación	Cuidados Respiratorios Integrales Hospital Manuela Beltrán E.S.E (Socorro /Sder) Hospital Regional de San Gil E.S.E (S. Gil / Sder)
Otros	Los puntos presentados en la charla derivan de la revisión de los datos actuales y las opiniones reflejan mi punto de vista



Visión general:

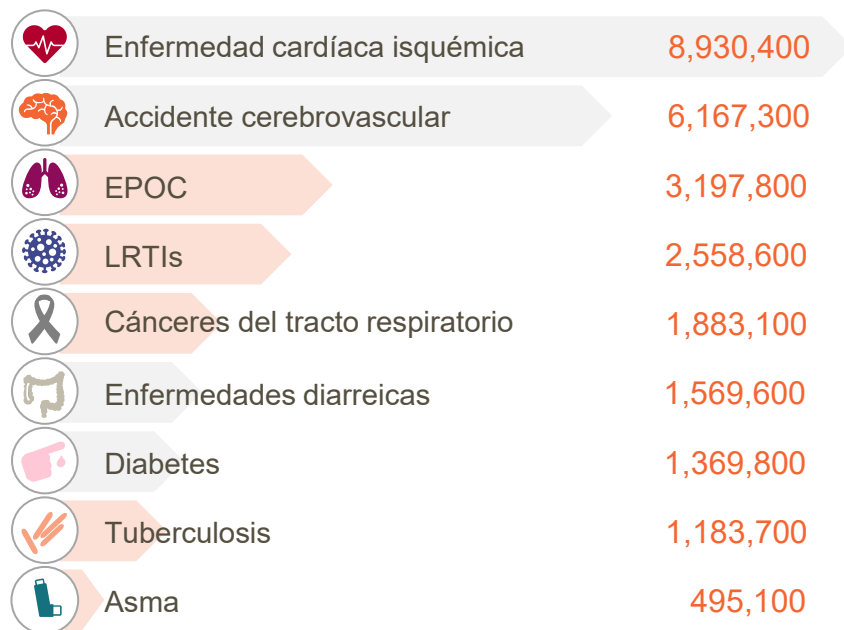
1. Enfermedades respiratorias: una de las principales causas globales de muerte y discapacidad
2. El papel de la vacunación en el manejo de pacientes con EPOC
3. Reducir la carga futura: priorizar la vacunación
4. Resumen



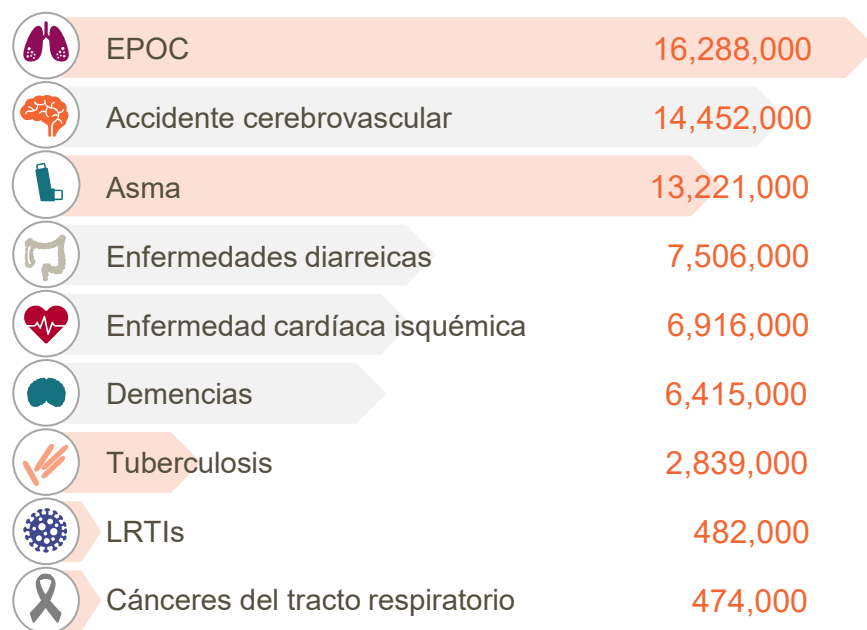
**Enfermedades respiratorias:
una de las principales causas globales de muerte y
discapacidad**

Las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial^{1,2}

Fallecimientos a nivel mundial, 2017*¹



Años vividos con discapacidad, 2016*²

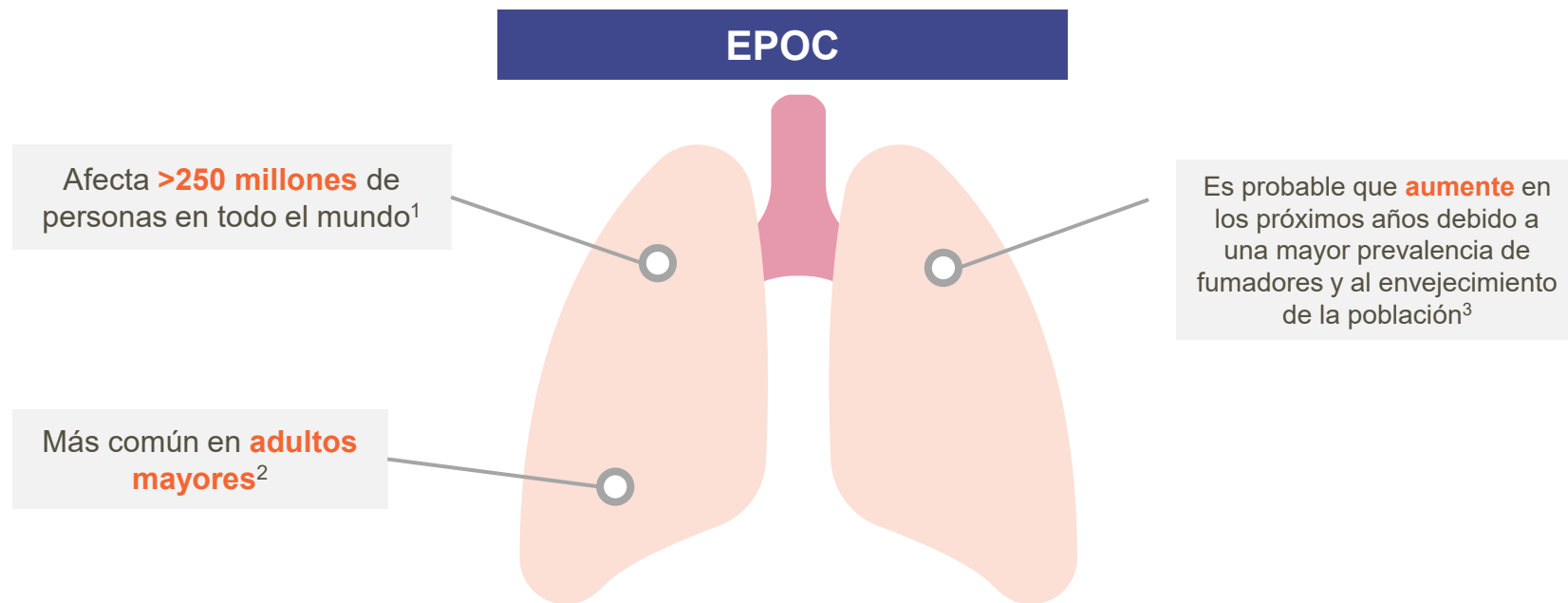


*los gráficos son conceptuales, para visualizar las cargas relativas de enfermedades, y no representan todas las enfermedades; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; LRTI, infección del tracto respiratorio inferior.

1. Global Burden of Disease 2017 Causes of Death Collaborators. *Lancet* 2018;392:1736–1788.

2. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. *Lancet* 2017;390:1211–59.

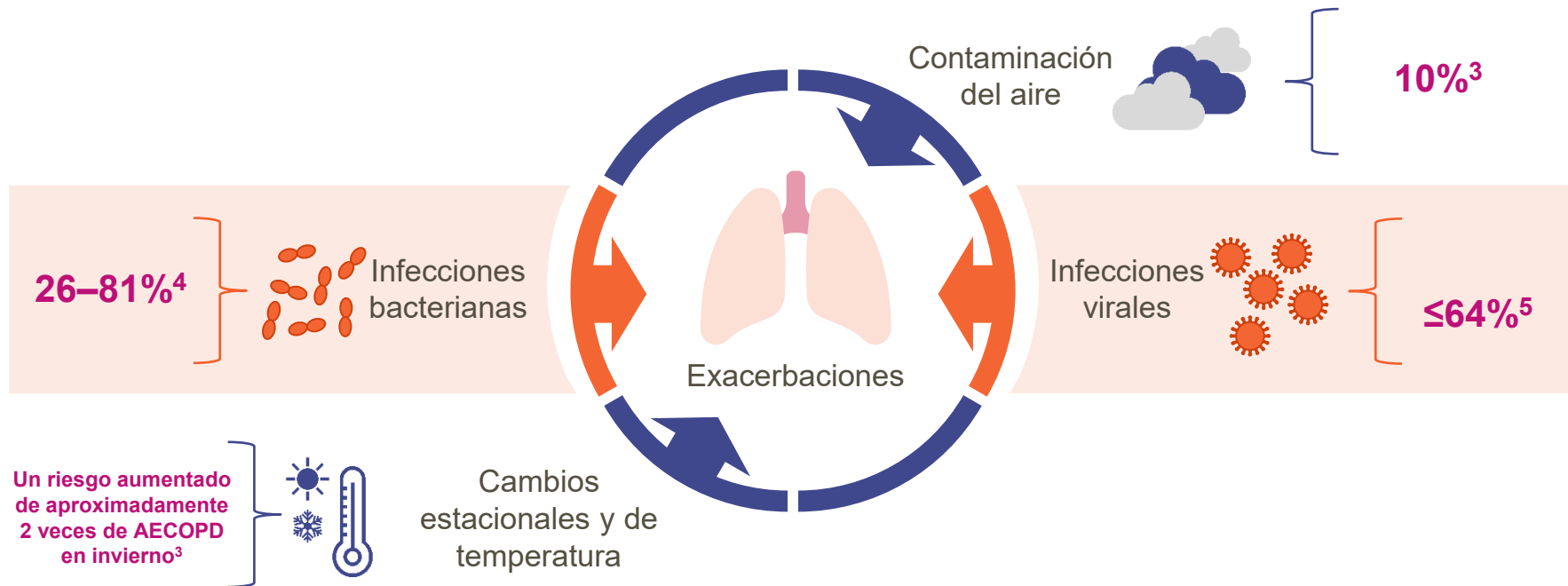
Las enfermedades respiratorias crónicas no transmisibles, como la EPOC, afectan a millones de personas en todo el mundo, y el número está en aumento



EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

1. GBD 2016. Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. *Lancet* 2017;390:1211–59. 2. Forum of International Respiratory Societies. *The Global Impact of Respiratory Disease*. 2nd edition. Sheffield: European Respiratory Society, 2017. 3. WHO, 2017. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-\(copd\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)). 4. Moorman JE et al. *MMWR Surveill Summ* 2007;56:1–54. 5. US Food & Drug Administration (FDA), 2018. Asthma: The Hygiene Hypothesis. <https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/consumers-biologics/asthma-hygiene-hypothesis> (URLs accedidos en enero de 2023).

Las infecciones se encuentran entre los contribuyentes más comunes a las exacerbaciones de la EPOC^{1,2}



AECOPD, exacerbación aguda de la EPOC; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

1. GOLD. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD. 2023 Report. www.goldcopd.org. 2. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2022. www.ginasthma.org. 3. Jenkins CR *et al.* *Eur Respir J* 2012;39:38–45. 4. Ko FW *et al.* *Respirology* 2016;21:1152–1165. 5. Hewitt R *et al.* *Ther Adv Respir Dis* 2016;10:158–174. (URLs accedidos en enero de 2023.)

El tratamiento para las enfermedades respiratorias crónicas es predominantemente reactivo, centrándose en el alivio de los síntomas y su manejo¹⁻⁴

■ Manejo de los síntomas ■ Terapia preventiva



EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICS, corticosteroides inhalados.

1. GOLD. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD. 2023 Report. www.goldcopd.org. 2. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2022. www.ginasthma.org. 3. NICE, 2021. Chronic obstructive pulmonary disease. <https://cks.nice.org.uk/chronic-obstructive-pulmonary-disease>. 4. NICE, 2022. Asthma. <https://cks.nice.org.uk/asthma> (URLs accedidas en enero de 2023).



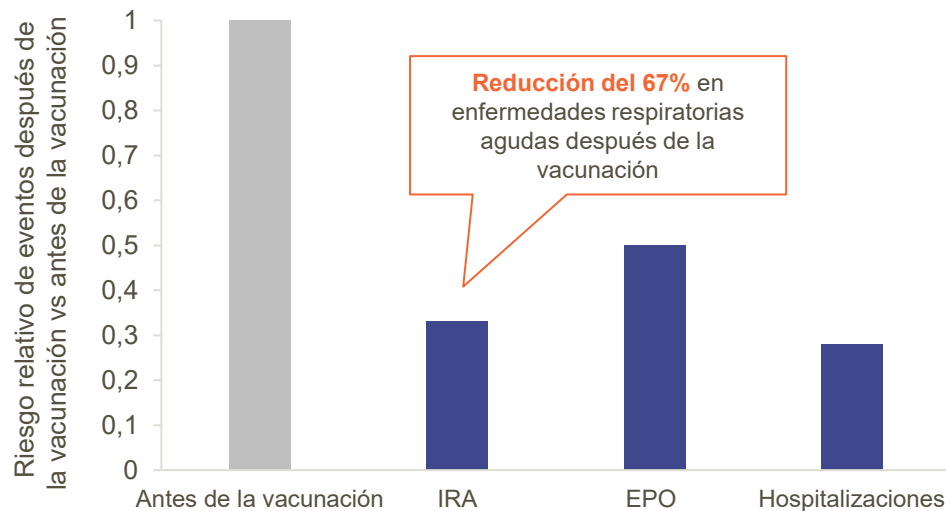
El papel de la vacunación en el manejo de pacientes con EPOC

La vacunación contra la influenza reduce significativamente el riesgo de exacerbaciones y hospitalización relacionada con la influenza en pacientes con EPOC^{1,2}

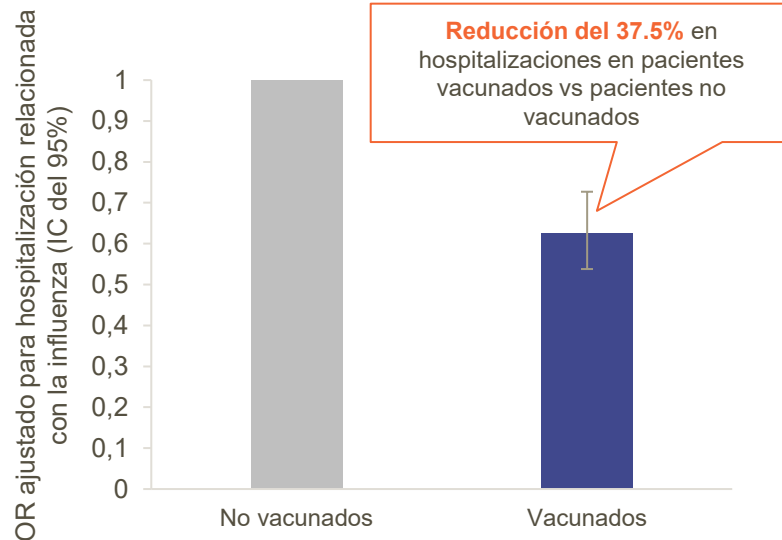
GSK



Seguimiento de 2 años en adultos mayores con EPOC después de la vacunación contra la influenza, India, 2004-2006 (n=87)¹



Hospitalizaciones relacionadas con la influenza en pacientes con EPOC, Canadá, 2011-2015 (n=4755)²



AECOPD, exacerbación aguda de la EPOC; IRA, enfermedad respiratoria aguda; IC, intervalo de confianza; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; EPO, enfermedad pulmonar obstructiva; OR, odds ratio; VE, eficacia de la vacuna.

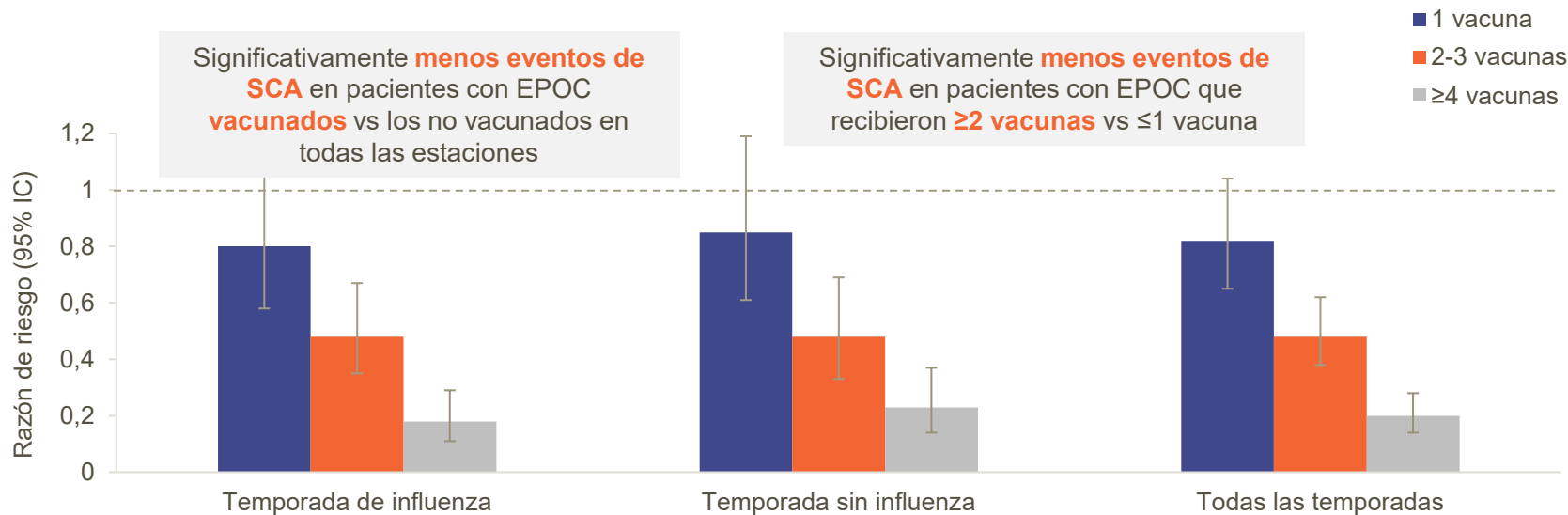
Gráficos creados por GSK a partir de datos de fuentes.

1. Menon B *et al.* *Int J Clin Pract* 2008;62:593–598. 2. Mulpuru S *et al.* *Chest* 2019;155:69–78.

La vacunación anual contra la influenza reduce el riesgo de hospitalización por síndrome coronario agudo en pacientes mayores con EPOC



Riesgo de síndrome coronario agudo durante un seguimiento de 8 años en pacientes con EPOC de ≥ 55 años que recibieron vacunación contra la influenza en comparación con pacientes no vacunados; Taiwán, 2000-2007 (n=7722; 3027 vacunados)



$P < 0.001$ para la tendencia general

SCA, síndrome coronario agudo; IC, intervalo de confianza; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Gráficos creados por GSK a partir de datos de la fuente.

Sung LC *et al.* *Vaccine* 2014;32:3843–3849.

La vacunación contra la influenza puede reducir el uso de antibióticos en adultos



Los estudios indicaron reducciones consistentes en el uso de antibióticos por parte de individuos vacunados, utilizando una variedad de resultados*

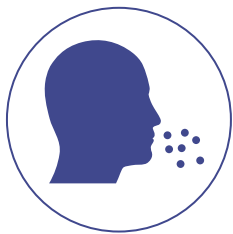
Población	No.	Edad	Temporada de influenza	Descripción del resultado	Resultado 95% IC / valor de P
Adultos mayores	237	51-101	Enero – Marzo 1999	Número de días de antimicrobianos – vía oral	Reducción del 42% 0.10
				Número de días de antimicrobianos – inyectados	Reducción del 66% <0.001
Adultos	1,616	NR	Febrero – Marzo 2000	Recibió antimicrobianos	Reducción del 66% 54%–75%
Estudiantes	12,796	18+	2002 – 2006	Uso de antimicrobianos	Reducción del 48% 10%–68%
Adultos	2,070	14-86	Febrero – Abril 1999	Uso de antimicrobianos	Reducción del 41% 28%–52%

*Estos resultados se han traducido en reducciones porcentuales a partir del resultado reportado en los manuscritos originales, para facilitar la comparación.

1. Hara Y *et al. Environ Health Prev Med.* 2002;7(5):183–188. 2. Mustafa AN *et al. Int J Infect Dis.* 2003;7(3):210–214. 3. Nichol, KL *et al. Arch Pediatr Adolesc Med.* 2008;162(12):1113-8. 4. Qureshi H *et al. Vaccine.* 2000;18(26):2956–2962.

La tos ferina en adultos a menudo pasa desapercibida, se diagnostica de forma errónea y se subreporta

Las características clínicas en adultos son **frecuentemente atípicas y no específicas**^{1,2}



El típico "quien" (whoop) a menudo está ausente²

Limitaciones en el **momento** y la **sensibilidad/especificidad** de las pruebas diagnósticas^{1,3}



Cultivo: alta especificidad pero baja sensibilidad



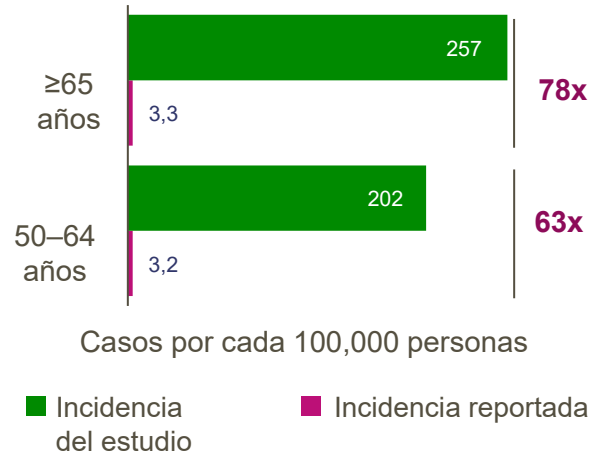
PCR: alta sensibilidad pero especificidad variable



Serología: se utiliza para el diagnóstico en fases posteriores de la infección

Para cuando la mayoría de los adultos buscan atención médica, ya ha pasado el tiempo para realizar cultivos y pruebas de PCR⁴

Se estima que la tos ferina es mucho **más común en adultos mayores de lo que se informa**^{*5}



*Basado en el análisis de una base de datos de reclamaciones de Estados Unidos⁵
PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Gráfico creado por GSK a partir de los datos de la fuente.

1. Moore A *et al.* *Chest* 2019;155:147–154. 2. Lee GM *et al.* *Clin Infect Dis* 2004;39:1572–1580. 3. WHO 2014 Laboratory Manual for the Diagnosis of Whooping Cough caused by *Bordetella pertussis*/Bordetella parapertussis. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/127891> (accedido en enero de 2023) 4. Cherry JD *et al.* *Clin Infect Dis* 2012;54:1756–1764. 5. Masseria C, Krishnarajah G. *BMC Infect Dis* 2015;15:534.

Existe una mayor carga de tos ferina en pacientes con EPOC



La EPOC más que duplica el riesgo
de tos ferina:

RR 2.53 (IC del 95%: 2.40-2.68)*†

EPOC/Asma

EPOC + tos ferina

↑ Carga de
enfermedad

↑ Costos de
atención médica

*Análisis retrospectivo de bases de datos en Estados Unidos (N=1313 casos de EPOC + tos ferina); †Comparado con pacientes sin asma ni EPOC; ‡Comparado con pacientes de tos ferina sin EPOC. CI, intervalo de confianza; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; RR, riesgo relativo.

El uso de vacunas Tdap en adultos mayores está respaldado por datos clínicos y del mundo real



Inmunogénico



- **Alta inmunogenicidad** en adultos y adultos mayores: **>98%** de seroprotección de difteria y tétanos y **>96%** de seropositividad de antígeno de tos ferina (≥ 65 años de edad, N=85-111)¹
- Inmunogénica como **dosis de refuerzo** administrada 10 años después de la primera dosis²

Tolerabilidad aceptable



- **Los datos de seguridad a largo plazo** de un amplio programa nacional de vigilancia de la seguridad de las vacunas (US VAERS) indican que **no se han identificado nuevas preocupaciones de seguridad** en personas de ≥ 65 años (n=1798 informes)³
 - Los AE locales/sistémicos más comunes: enrojecimiento, dolor e hinchazón, fiebre

Efectividad significativa



- La eficacia de la vacuna Tdap contra la tos ferina en adultos mayores (edad media de 61 años) en un estudio de casos y controles anidado fue del **52%** (IC del 95%: 15-73%)⁴

AE, evento adverso; IC, intervalo de confianza; Tdap, difteria de baja dosis, tétanos de alta dosis, tos ferina acelular de baja dosis; VAERS, sistema de reporte de eventos adversos de vacunas; VE, eficacia de la vacuna.

1. Asatryan A *et al. Hum Vaccin Immunother* 2020 Aug 26;1-8. doi: 10.1080/21645515.2020.1796423. 2. Ridda I *et al. Vaccine* 2012;30:6745–6752.

3. Haber P *et al. Vaccine* 2020;38:1476–1480. 4. Liu BC *et al. Clin Infect Dis* 2020;71:340–350.

El herpes zóster es una enfermedad dolorosa que puede tener complicaciones graves y duraderas^{1,2}



Presentación aguda de HZ

- Erupción vesicular unilateral¹
- Dolor que puede ser “agonizante”¹

Complicaciones

del estudio ZOE-50³

Neuralgia postherpética (NPH)

- Dolor neuropático que persiste durante >3 meses después de un brote de HZ⁴
- Afecta hasta el 30% de los pacientes con HZ²

Herpes zóster oftálmico (HZO)

- Afecta hasta el 25% de los pacientes con HZ¹
- En casos raros, puede causar pérdida de visión¹

Otras complicaciones

- Eventos cardiovasculares y cerebrovasculares⁵
- Pérdida de audición¹
- Cicatrización¹
- Compromiso craneal⁶

Los síntomas y complicaciones del HZ pueden ser más graves y de mayor duración en pacientes inmunocomprometidos^{7,8}

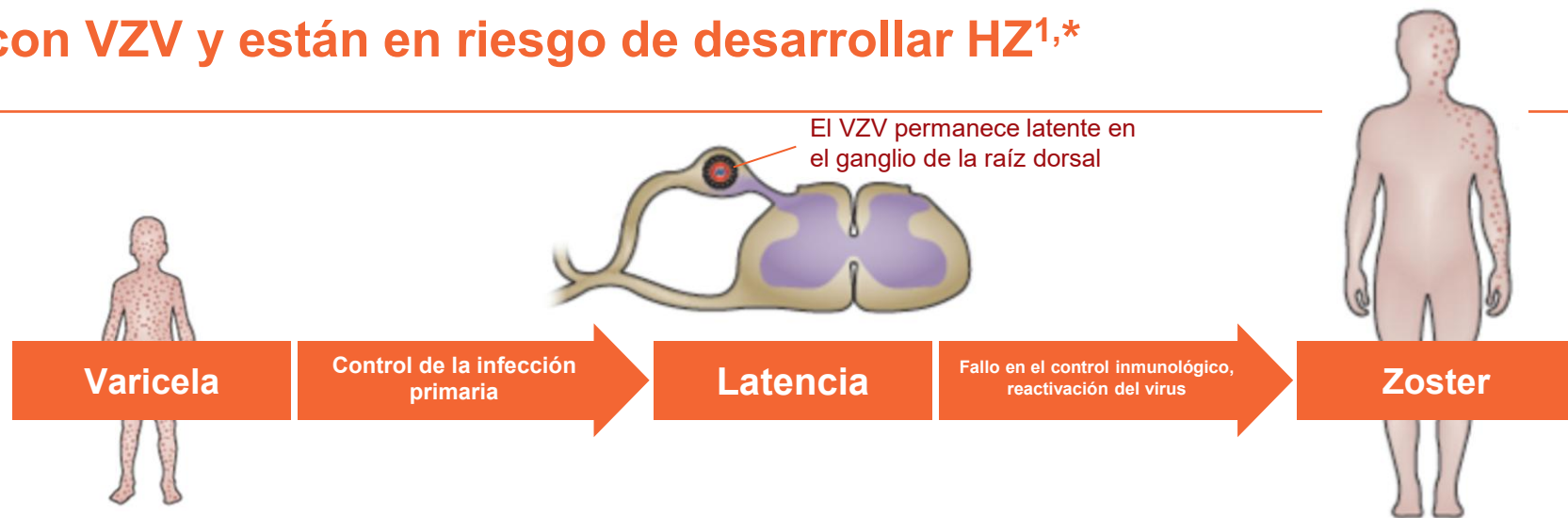


HZ, herpes zóster. Imágenes protegidas por derechos de autor utilizadas con permiso bajo licencia.

1. Harpaz R, et al. *MMWR Recomm Rep*. 2008 Jun;57(RR-5):1-30. 2. Kawai K, et al. *BMJ Open*. 2014 Jun;4(6):e004833. 3. Curran D, et al. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2019 Dec;25(12):2474-2481. 4. Mallick-Searle T, et al. *J Mult Healthcare*. 2016 Sep;21(1):447-454. 5. Erskine N et al. *PLoS ONE* 2017;12: e0181565. 6. Volpi A. *Herpes*. 2007 Sep;14 Suppl 2:35-9. 7. McKay SL, et al. *Clin Infect Dis*. 2019 Nov;ciz1090. 8. Kennedy PGE, et al. *Viruses*. 2018;10(11):609.

El 99.5% de los adultos ≥ 50 años de edad están infectados con VZV y están en riesgo de desarrollar HZ^{1,*}

GSK



- **1 de cada 3** personas en Estados Unidos desarrollará herpes zóster en su vida debido a la reactivación del VZV¹
- Las tasas de incidencia son similares en América del Norte, Europa y la región de Asia-Pacífico (6-8 casos por 1000 personas-año a los 60 años)³
- Cada año, se estima que hay **1 millón** de nuevos casos de herpes zóster en Estados Unidos, 1.7 millones en Europa y **1.5 millones** en China^{1,4,5}

*Datos de Estados Unidos. Puede que no sean representativos de la población global.

VZV, virus varicela zóster.

Esta ilustración ha sido creada de forma independiente por GSK a partir de información publicada por primera vez en la National Review of Microbiology.²

1. Harpaz R, et al. *MMWR Recomm Rep*. 2008 June;57(RR-5):1-30. 2. Zerboni L, et al. *Nat Rev Microbiol*. 2014 Mar;12 (3):197-210.

3. Kawai K, et al. *BMJ Open*. 2014 Jun;4(6):e004833. 4. Pinchinat S, et al. *BMC Infect Dis*. 2013 April;13(170):1471-2334.

5. Li Y, et al. *Open Forum Infect Dis*. 2016 Mar;3(2):ofw067.

Riesgo de herpes zóster en pacientes con EPOC



- La EPOC ha sido identificada como un factor de riesgo para el herpes zóster (HZ) y la neuralgia postherpética (PHN)¹⁻³
- Un análisis retrospectivo de una base de datos de reclamaciones de Estados Unidos de 2013-2018 mostró que la EPOC es un **factor de riesgo estadísticamente significativo para el desarrollo de episodios agudos de HZ** en adultos de ≥ 40 años y, entre los adultos de ≥ 50 años con HZ, **la presencia de EPOC también aumentó el riesgo de PHN**. Esta asociación fue principalmente observada en personas de 70-79 años⁴

“Es razonable hipotetizar que la disregulación inmunológica encontrada en la EPOC puede aumentar el riesgo de desarrollar herpes zóster en los pacientes. Además, los corticosteroides inhalados o sistémicos utilizados para el manejo de la EPOC pueden aumentar la susceptibilidad al herpes zóster al suprimir la función inmunológica normal.”⁵

Los proveedores de atención médica pueden enfocar la educación del paciente en función de sus factores de riesgo y mejorar la aceptación de la vacuna contra el zóster²

EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HZ, herpes zóster; PHN, neuralgia postherpética.

1. Kawai K & Yawn BP. *Mayo Clin Proc.* 2017;92:1806-1821. 2. Marra *et al.* *OFID.* 2020; 9;7(1):ofaa005. DOI: 10.1093/ofid/ofaa005. 3. Safonova E *et al.* *Respir Res.* 2023;24:35. <https://doi.org/10.1186/s12931-022-02305-1>. 4. Thompson-Leduc P *et al.* *Clin Respir J.* 2022;16:826–834. 5. Yang YW *et al.* *CMAJ.* 2011;183(5).

La eficacia de la vacuna contra el herpes zóster (HZ) es alta, incluso en pacientes con comorbilidades respiratorias



- Eficacia de la vacuna (VE) según la condición basal actual (análisis combinado de ZOE-50/70, sujetos ≥50 años de edad)¹
- Cohorte vacunada total modificada: Primer o único episodio de HZ durante todo el período del estudio según la condición basal utilizando el método de Poisson.

	Vacuna recombinante zóster		Placebo		VE% (IC 95%)
Condición médica	No.	Tasa de HZ/1000 personas-año	No.	Tasa de HZ/1000 personas-año	
Asma	646	1.2	689	10.9	88.8 (63.6–97.8)
Trastornos respiratorios distintos del asma	614	1.4	560	8.7	84.5 (46.4–97.1)

No. = número de sujetos incluidos en cada grupo.

1. Oostvogels L *et al*, *Hum Vaccin Immunother*. 2019;15(12):2865-2872.

Directrices y recomendaciones actuales para RZV*



Población general (≥50 años de edad)

- US Advisory Committee on Immunization Practices¹
- Canadian National Advisory Committee on Immunization²
- Australian National Centre for Immunization Research & Surveillance³
- German Standing Committee on Vaccination (STIKO)²⁰
- Italy Ministry of Health²¹
- Swiss Federal Office of Public Health²²
- Saudi Arabia Ministry of Health²³



Comorbilidades comunes

Diabetes Mellitus

- US Advisory Committee on Immunization Practices¹
- American Diabetes Association¹²

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

- US Advisory Committee on Immunization Practices¹
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)¹³

Asma

- US Advisory Committee on Immunization Practices¹



Enfermedades autoinmunes

Artritis Reumatoide

- US Advisory Committee on Immunization Practices¹
- European League Against Rheumatism (EULAR) 2019^{4,5}

Lupus Eritematoso Sistémico

- US Advisory Committee on Immunization Practices^{6,7}

Enfermedad Inflamatoria Intestinal

- US Advisory Committee on Immunization Practices^{6,7}
- American College of Gastroenterology 2017⁸
- Crohn's and Colitis Foundation⁹
- European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) Guidelines 2021¹⁰

Artritis Psoriásica/Psoriasis

- US Advisory Committee on Immunization Practices^{6,7}
- National Psoriasis Foundation¹¹

Esclerosis Múltiple

- US Advisory Committee on Immunization Practices^{6,7}

Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas

- American College of Rheumatology¹⁹



Inmunocomprometido (≥18/50 años de edad)

Cáncer

- US Advisory Committee on Immunization Practices^{6,7}
- NCCN Survivorship Guideline (V1.2022)¹⁴
- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology and Prevention and Treatment of Cancer-related Infections¹⁵

Trasplante de Órgano Sólido/Renal

- US Advisory Committee on Immunization Practices^{6,7}
- American Society of Transplantation¹⁶

Virus de Inmunodeficiencia Humana

- US Advisory Committee on Immunization Practices^{6,7}
- European AIDS Clinical Society¹⁷

Mieloma Múltiple

- European Myeloma Network¹⁸

*Descargo de responsabilidad: La tabla es inclusiva pero no es una lista exhaustiva de todas las recomendaciones de la sociedad para la vacuna recombinante contra el herpes zóster o la protección contra el herpes zóster

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; NCCN: National Comprehensive Cancer Network.

(Referencias en la siguiente diapositiva)

Directrices y recomendaciones actuales para RZV

Referencias de la diapositiva anterior

1. Dooling KL *et al.* *MMWR Morb Mortal Wkly rep* 2018;67: 103-108; 2. Public Health Agency of Canada. An advisory committee statement (ACS) National Advisory Committee On Immunization (NACI): updated recommendations of the Use of Herpes Zoster Vaccines. <https://www.canada.ca/en/services/health/publications/healthy-living/updatedrecommendations-use-herpes-zoster-vaccines.html>.
 3. NCIRS. Fact Sheet: Zoster Vaccines for Australian Adults. Nov 2021. 4. EULAR. Vaccination for people with AIIRD. https://www.eular.org/myUploadData/files/vaccination_summary_good_for_print_final.pdf.
 5. Furer V *et al.* *Ann Rheum Dis* 2020;79:39–52.
 6. Anderson TC *et al.* *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2022;71:80-84. 7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). ACIP Meeting October 20, 2021 Presentation Slides. <https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-10-20-21/02-ZosterVaccines-Anderson-508.pdf>.
 8. Farraye FA *et al.* *Am J Gastroenterol* 2017;112:241–258. 9. Crohn's and Colitis Foundation. Health Maintenance Summary. <https://www.crohnscolitisfoundation.org/sites/default/files/2019-09/Health%20Maintenance%20Checklist%202019-3.pdf>.
 10. Schreiner P; *Journal of Crohn's and Colitis*; 2021;15:316-325. 11. Baumrin E *et al.* *J Am Acad Dermatol* 2019;81:102-110.
 12. American Diabetes Association. *Diabetes Care* 2021;44(Suppl 1):S40–S52. 13. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). 2023 Report. www.goldcopd.org.
 14. NCCN Guidelines. Survivorship V1.2022. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/survivorship.pdf.
 15. NCCN Guidelines. Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections. V1.2022. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/infections.pdf.
 16. Pergam SA, Limaye AP. *Clin Transplant* 2019;33:e13622. 17. European AIDS Clinical Society (EACS). Vaccination. <https://eacs.sanfordguide.com/prevention-non-infectious-co-morbidities/vaccination>.
 18. Ludwig H *et al.* *Leukemia* 2021;35:31–44;2. 19. American College of Rheumatology. Guideline for Vaccinations in Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. <https://www.rheumatology.org/Portals/0/Files/Vaccinations-Guidance-Summary.pdf>.
 20. German Standing Committee on Vaccination (STIKO) at the Robert Koch Institute (RKI) Epidemiological bulletin No. 50. 2018. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2018/Ausgaben/50_18.pdf?__blob=publicationFile.
 21. Italy Ministry of Health. Update on herpes zoster vaccine (2021). <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79080&parte=1%20&serie=null>.
 22. Sweden Folkhalsomyndigheten. Vaccine against shingles (herpes zoster). <https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/baltros/>.
 23. Saudi Arabia Ministry of Health. *National Immunization Schedule (2019)*. <https://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/EducationalContent/HealthTips/Documents/Immunization-Schedule.pdf>.
- (URLs accedidas en enero de 2023.)

¿Es efectiva la vacunación neumocócica para prevenir la neumonía en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica?



Resultados	Efecto relativo OR (95% IC) % de reducción	Número de participantes (estudios)	Calidad de la evidencia
NAC al menos un episodio Seguimiento: rango de 6 a 36 meses	0.59 (0.41; 0.85) 41%	1372 (6 ECA)	Moderado
Neumonía neumocócica, al menos un episodio Seguimiento: rango de 6 a 36 meses	0.26 (0.05; 1.31) 74%	1158 (3 ECA)	Bajo
Admisión hospitalaria: cualquier causa, al menos un episodio Seguimiento: rango de 6 a 12 meses	0.74 (0.32; 1.74) 26%	391 (3 ECA)	Moderado
Exacerbación de la EPOC: al menos un episodio	0.60 (0.39; 0.93) 40%	446 (4 ECA)	Moderado

La vacunación neumocócica se asocia con una reducción en la neumonía y las exacerbaciones de la EPOC

Recomendación para el uso de las vacunas conjugadas neumocócicas en adultos según el CDC-ACIP^{1,2}

Basado en la edad:

*Los adultos de 65 años de edad o más que no hayan recibido previamente una vacuna conjugada neumocócica o cuyo historial de vacunación anterior sea desconocido deben recibir una vacuna neumocócica (ya sea **PCV20** o **PCV15**). Si se utiliza **PCV15**, esto debe ser seguido por una dosis de **PPSV23**.*

Basado en el riesgo:

*Los adultos de 19 a 64 años de edad con ciertas condiciones médicas subyacentes u otros factores de riesgo que no hayan recibido previamente una vacuna conjugada neumocócica o cuyo historial de vacunación anterior sea desconocido deben recibir una vacuna neumocócica (ya sea **PCV20** o **PCV15**). Si se utiliza **PCV15**, esto debe ser seguido por una dosis de **PPSV23**.*

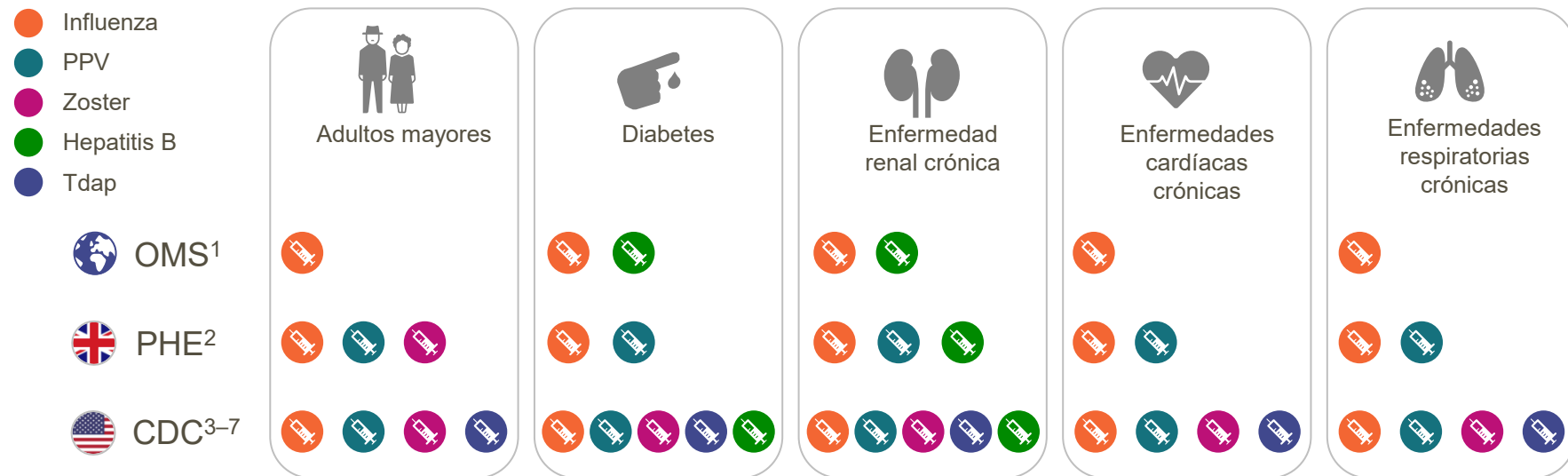
1. IDSE November 2021. ACIP Recommends Pneumococcal Vaccines for Certain Immunocompromised Adults <https://www.idse.net/Bacterial-Infections/Article/11-21/ACIP-Recommendations-Pneumococcal-Vaccines-for-Certain-Immunocompromised-Adults/65169>.

2. Use of 15-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 20-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine Among U.S. Adults: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices — United States, 2022 at <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104a1.htm>. (URLs consultadas en enero de 2023).



**Reducir la carga futura:
priorizar la vacunación**

Dado el mayor riesgo de resultados graves de las enfermedades prevenibles por vacunación (VPDs, por sus siglas en inglés) en adultos mayores y adultos con condiciones de riesgo, se recomienda la vacunación a nivel mundial



La vacunación de rutina puede reducir la carga general en los sistemas de salud y **ayudar a mejorar los resultados del COVID-19**^{8,9,10}

CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; PHE, Salud Pública de Inglaterra; PPV, vacuna neumocócica polisacárida; Tdap, vacuna contra el tétanos, difteria y polio; VPD, enfermedad prevenible por vacunación; OMS, Organización Mundial de la Salud.

1. WHO 2022. WHO recommendations for routine immunization - summary tables. <https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/policies/who-recommendations-for-routine-immunization---summary-tables>. 2. UK Health Security Agency. <https://www.gov.uk/government/publications/the-complete-routine-immunisation-schedule/the-complete-routine-immunisation-schedule-from-february-2022>. 3. CDC 2016. Diabetes Type 1 and Type 2 and Adult Vaccination. <https://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/health-conditions/diabetes.html>. 4. CDC 2016. Renal Disease and Adult Vaccination. <https://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/health-conditions/renal-disease.html>. 5. CDC 2016. Heart Disease, Stroke, or Other Cardiovascular Disease and Adult Vaccination. <https://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/health-conditions/heart-disease.html>. 6. CDC 2016. Lung Disease including Asthma and Adult Vaccination. <https://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/health-conditions/lung-disease.html>. 7. CDC 2019. What Vaccines are Recommended for You. <https://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/index.html>. 8. Agarwal U et al. Lancet 2020;400:1305-20. 9. Arbel R et al. Lancet 2023 Preprint available online at: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4314067>. 10. Andre FE et al. Bull World Health Organ 2008;86:140-146. (URLs accedidas en enero de 2023.)



GSK

Resumen



Las enfermedades respiratorias crónicas, como la EPOC, están asociadas a una carga significativa para la salud y la economía a nivel mundial^{1,2}



Las infecciones virales respiratorias, incluyendo la influenza y la tos ferina, aumentan las exacerbaciones, hospitalizaciones y mortalidad en pacientes con EPOC³⁻⁵



La vacunación ayuda a reducir el riesgo de hospitalización, eventos cardiovasculares y exacerbaciones en pacientes con EPOC^{6,7,8}



Priorizar la vacunación en la atención rutinaria de enfermedades respiratorias podría reducir la gravedad y la carga de la enfermedad más allá del manejo actual^{6,7}

Material exclusivo para profesionales de la salud

Material elaborado por GSK

Si usted desea mayor información o reportar una situación clínica desfavorable ocurrida durante el uso de un producto de GlaxoSmithKline, favor comunicarse al teléfono 01 8000 1186 86 o escribir al correo electrónico: programa.dirmedica@gsk.com

GlaxoSmithKline Colombia S.A., Calle 26 # 69B-45 Edificio Bogotá Corporate Center Piso 9. Solicite mayor información científica de nuestros productos en nuestro servicio de información médica, a través del email mila@gsk.com

Fecha de elaboración: Abril 2024

Código PPT: NX-CO-RS-PPT-240019

Código video: NX-CO-RS-VID-240019

ACTUALIZA TUS
**CONOCIMIENTOS
MÉDICOS**

CURSOS GRATUITOS

CON CERTIFICACIÓN



ASMA DEL ADULTO



EPOC



FUNCIÓN PULMONAR



ASMA GRAVE



OTRAS ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS



VACUNAS

ACCEDA A NUESTRA PLATAFORMA



Material exclusivo para profesionales de la salud | Material elaborado por GSK | Si usted desea mayor información o reportar una situación clínica desfavorable ocurrida durante el uso de un producto de GlaxoSmithKline, favor comunicarse al teléfono 01 8000 1186 86 o escribir al correo electrónico: programa.dirmedica@gsk.com | GlaxoSmithKline Colombia S.A., Avenida Calle 116 No. 7 - 15, Interior 2, Oficina 601A, Bogotá D.C. | Solicite mayor información científica de nuestros productos en nuestro servicio de información médica, a través del email mila@gsk.com